Le système tégumentaire

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Cours et application

Enveloppe protectrice

La peau constitue une interface avec l'environnement. Elle contribue à la protection, à la sensibilité et à la thermorégulation. Son intégrité dépend des tissus, de la perfusion, de l'hydratation et des contraintes mécaniques.

Épiderme

Couche superficielle organisée en plusieurs assises cellulaires. Les kératinocytes participent à la barrière ; les mélanocytes interviennent dans la pigmentation. L'épiderme n'est pas vascularisé et reçoit ses apports par les tissus sous-jacents.

Derme et hypoderme

Le derme contient un tissu de soutien, des vaisseaux et des structures nerveuses. L'hypoderme comporte notamment du tissu adipeux et participe aux réserves, à l'isolation et à l'amortissement. Ces couches ont des fonctions complémentaires.

Annexes

Poils, ongles, glandes sébacées et glandes sudoripares complètent l'organisation cutanée. Sébum et sueur participent à l'environnement de la peau ; leur rôle ne se résume pas à l'aspect esthétique.

Observer une lésion

Décrire localisation, étendue, couleur, chaleur, douleur, relief, profondeur apparente, écoulement et évolution. Une lésion doit être décrite avant d'être interprétée. Rechercher les contraintes d'appui, l'humidité et les dispositifs en contact.

Lien avec les soins

Préserver la barrière cutanée, prévenir les lésions de pression, adapter les soins d'hygiène et surveiller les zones fragiles. Le diaporama transmis constitue ici la source anatomique ; la présence du fichier ne démontre pas l'écoute de ses éventuels commentaires.

Périmètre du cours

Le diaporama comporte aussi dermatologie, eczéma, plaies, cicatrisation et pansements. Cette nouvelle fiche traite les bases anatomiques et l'observation ; elle ne remplace pas tous ces chapitres, dont certains sont déjà présents dans le classeur B3.

Structure et fonctions de la peau

L’épiderme est la couche superficielle. Il se renouvelle à partir de cellules qui se différencient progressivement. Les kératinocytes contribuent à la barrière cutanée. Les mélanocytes participent à la pigmentation. D’autres cellules contribuent notamment à la défense et à la sensibilité ; la peau constitue un organe vivant, et non une simple enveloppe inerte.

Le derme soutient l’épiderme. Il contient un tissu conjonctif, des vaisseaux et des éléments nerveux. Ses propriétés mécaniques dépendent de ses constituants. L’hypoderme, plus profond, contient notamment du tissu adipeux ; il participe aux réserves énergétiques, à l’isolation et à l’amortissement.

La barrière cutanée limite les pertes hydriques et la pénétration de certaines substances. Son altération peut favoriser irritation, inflammation ou infection. Les effets d’un produit dépendent aussi du site, de l’intégrité de la peau, de la surface et des conditions d’utilisation. Un produit cutané n’a pas nécessairement un effet limité au seul point d’application.

La peau contribue à la thermorégulation par les échanges avec l’environnement, la circulation cutanée et la sudation. Les récepteurs sensoriels participent à la perception du contact, des variations thermiques et d’autres stimulations. Une modification de sensibilité doit être prise en compte dans la prévention des blessures et brûlures.

Annexes et observation dermatologique

Les annexes comprennent l’appareil pilaire, les glandes et les ongles. Le follicule pileux produit le poil ; les glandes sébacées contribuent au sébum. Les glandes sudoripares eccrines ont un rôle important dans la sudation et la thermorégulation. Les glandes apocrines ont une distribution et des caractéristiques différentes.

Les ongles protègent l’extrémité des doigts et participent aux prises fines. Lors d’un recueil, observer les modifications sans poser un diagnostic sur l’aspect seul. La coloration, la fragilité ou une déformation doivent être décrites et reliées au contexte.

Une description cutanée précise indique la localisation, le nombre, l’étendue, la couleur, le relief, l’état de surface et les symptômes. Rechercher prurit, douleur, chaleur, écoulement et évolution. Une photographie, lorsqu’elle est autorisée et réalisée selon la procédure, doit respecter consentement et confidentialité.

Devant un eczéma évoqué dans le diaporama, repérer les symptômes et les facteurs possibles avec l’équipe. L’étiologie et le traitement ne se déduisent pas du seul mot « rougeur ». Les produits appliqués, les expositions et les antécédents sont des informations pertinentes à recueillir.

Plaies cicatrisation et lien avec les soins

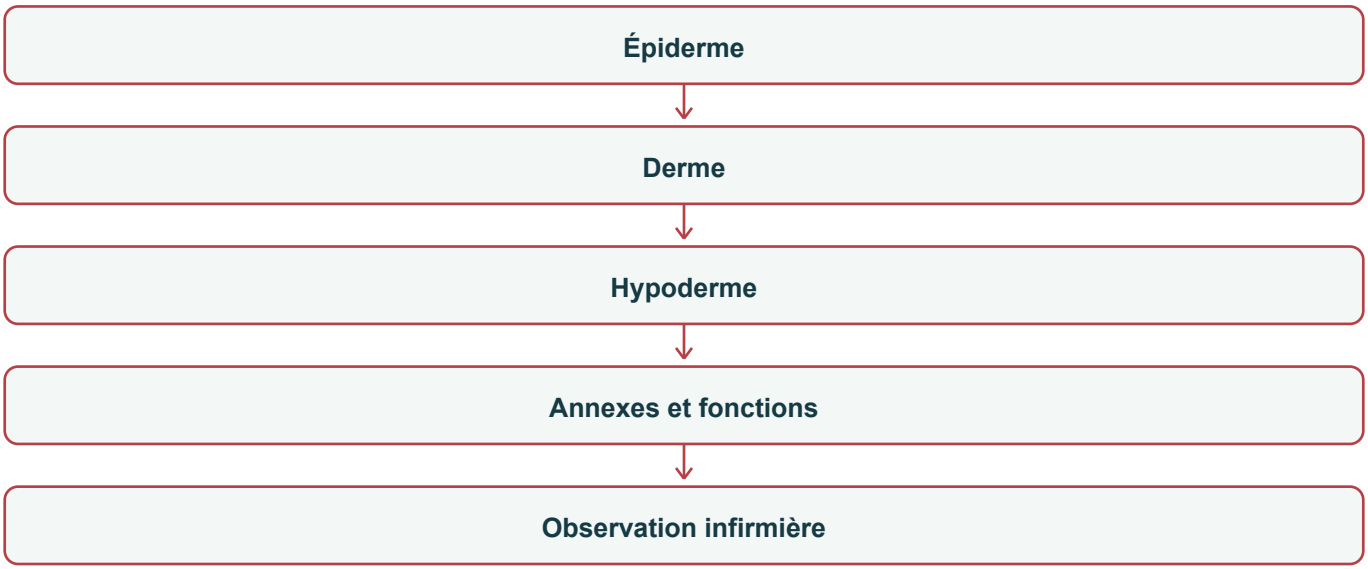
Une plaie s’évalue dans son ensemble : cause, ancienneté, localisation, dimensions, profondeur, tissu observé, exsudat, douleur et peau périphérique. Le terrain et la perfusion influencent l’évolution. Le traitement local ne remplace pas la prise en compte de la cause et des facteurs qui ralentissent la cicatrisation.

Le diaporama aborde détersion, granulation et épidermisation ainsi que plusieurs familles de pansements. Leur choix dépend notamment de la phase, de l’exsudat, de la peau périphérique et de l’indication. Les durées d’utilisation et précautions se vérifient pour le dispositif précis ; une règle générale ne doit pas remplacer sa notice.

Colonisation et infection ne sont pas synonymes. L’interprétation associe l’aspect, l’évolution, les signes locaux et généraux et le terrain. Les prélèvements et traitements sont décidés selon la situation. Le sérum physiologique et le savon ne doivent pas être présentés comme des antiseptiques, même si une diapositive les compare dans le nettoyage des plaies.

Les cours existants du classeur B3 détaillent déjà plaies, cicatrisation et escarres. Ce complément B1 relie l’anatomie et les fonctions de la peau à l’observation et aux soins. Il ne remplace pas les protocoles, les notices ni l’évaluation clinique requise pour choisir un pansement.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Quelle couche est superficielle ? L’épiderme.

Le derme contient-il des vaisseaux ? Oui.

Avant de nommer une lésion, que faire ? La décrire précisément.

Sources et portée

UE B1 CM Système tégumentaire Dr DUGOURD 260901.pptx

Ressource Moodle correspondante